

Rapport de Situation de la 17^e Épidémie de la maladie à Virus EBOLA /RDC

SitRep N°137/MVE-BDBV/28/09/2026

Date du rapport : 28 septembre 2026

Date de publication : 29 septembre 2026



FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

- En date du 28 Septembre, 55 nouveaux cas confirmés de la Maladie à Virus Ebola (MVE), dont 17 décès communautaires ont été notifiés. Les cas confirmés rapportés étaient répartis dans les provinces de l'Ituri (36 cas), du Nord-Kivu (12 cas), du Haut-Uélé (5 cas) et à la Tshopo (2 cas). De plus, 13 décès ont été enregistrés dans les CTE.
- Un total de 380 nouveaux échantillons a été analysé; 55 de ces échantillons se sont révélés positifs au virus Bundibugyo, soit 14,5 % de positivité.
- Aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée au cours des dernières 24 heures.

CUMUL DES
CAS
8 171

CUMUL DES
DÉCÈS
CONFIRMÉS
3 954

LETALITE
48,4 %

PATIENTS EN
ISOLEMENT/CTE
759

CUMUL DES
GUÉRIS
2 105

TAUX DE SUIVI DES
CONTACTS
(Du Jour)
82,0 %



Provinces touchées et zones de santé touchées



7 Provinces touchées
Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Tshopo, Bas-Uélé et
Sud Ubangi



63 Zones de santé touchées sur 167 (37,7%)

Résumé des points clés au cours des dernières 24 heures

Cinquante-cinq (55) nouveaux cas confirmés de la Maladie à Virus Ebola (MVE) dont **17 décès communautaires** ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Les provinces ayant rapporté ces cas sont celles de l'Ituri (36 cas), du Nord-Kivu (12 cas), du Haut-Uélé (5 cas) et de la Tshopo (2 cas).

Par ailleurs, **13 décès ont été enregistrés dans les CTE** (11 en Ituri, 1 au Nord-Kivu et 1 au Haut-Uélé), ce qui porte à 30, le nombre total des décès confirmés pour la période considérée.

Au terme de cette même journée, 17 patients (**11 en Ituri, 4 à la Tshopo et 2 au Bas-Uélé**) ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs à la MVE.

Au **28 septembre 2026**, la RDC cumule **8 171 cas confirmés et 3 954 décès** (létalité : **48,4 %**). L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie avec **76,1 %** des cas confirmés cumulés rapportés et **65,5 %** des nouveaux cas confirmés. En revanche, la province du Nord-Kivu présente une létalité supérieure à la moyenne nationale, soit **59,4%**.

Au total, **63 zones de santé sur 167 (37,7 %)**, réparties dans **sept provinces**, ont été touchées depuis le début de l'épidémie.

Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 28 septembre 2026.

Province	Nouveaux cas confirmés(24h)	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées
Ituri	36	6218	2 868	46,1%	28/36 (77,8 %)
Nord-Kivu	12	1553	922	59,4%	16/34 (47,1 %)
Haut-Uélé	5	340	142	41,8%	7/13 (53,8 %)
Tshopo	2	45	16	35,6%	7/23 (30,4 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)
Bas-Uélé	0	10	4	40,0%	3/11 (27,3%)
Sud Ubangi	0	2	1	50,0%	1/16 (6,3%)
Total	55	8 171	3 954	48,4%	63/167 (37,7 %)

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone au 28 septembre 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	6218	2868	46,1%	36	9	11	20
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	8	6	75,0%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	202	46	22,8%				0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1714	557	32,5%	9	4	3	7
Damas	40	9	22,5%				0
Drodro	15	7	46,7%				0
Fataki	82	31	37,8%				0
Gethy	7	3	42,9%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	35	12	34,3%				0
Komanda	168	101	60,1%	1	0	0	0
Lita	284	143	50,4%	1	1	1	2
Logo	13	5	38,5%				0
Lolwa	33	8	24,2%				0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	29	11	37,9%				0
Mandima	131	71	54,2%	11	4	0	4
Mangala	350	153	43,7%	4	0	0	0
Mongbwalu	700	330	47,1%	2	0	2	2
Nia-Nia	295	161	54,6%	2	0	2	2
Nizi	775	279	36,0%	3	0	1	1
Nyankunde	128	37	28,9%				0
Rimba	12	4	33,3%				0
Rwampara	1082	365	33,7%	3	0	2	2

Tchomia	76	25	32,9%				0
A ventiler *	NA	493	NA				0
Nord-Kivu	1553	922	59,4%	12	7	1	8
Beni	343	228	66,5%	6	6	0	6
Biena	18	7	38,9%				0
Butembo	258	167	64,7%	1	0	1	1
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	54	18	33,3%	1	0	0	0
Katwa	559	355	63,5%				0
Kayna	1	0	0,0%				0
Kyondo	33	20	60,6%				0
Lubero	21	11	52,4%				0
Mabalako	32	11	34,4%	1	0	0	0
Manguredjipa	13	5	38,5%				0
Masereka	28	9	32,1%				0
Musienene	123	66	53,7%	1	0	0	0
Mutwanga	12	2	16,7%				0
Oicha	26	14	53,8%				0
Vuhovi	31	9	29,0%	2	1	0	1
Haut-Uélé	340	142	41,8%	5	1	1	2
Boma Mangbetu	39	17	43,6%				0
Dungu	1	1	100,0%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	102	44	43,1%	1	1	0	1
Pawa	83	38	45,8%	3	0	1	1
Rungu	2	1	50,0%				0
Wamba	110	40	36,4%	1	0	0	0
Tshopo	45	16	35,6%	2	0	0	0
Bafwasende	7	1	14,3%				0
Kabondo	5	1	20,0%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	24	10	41,7%	1	0	0	0
Mangobo	6	3	50,0%	1	0	0	0
Tshopo	1	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	10	4	40,0%	0	0	0	0
Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	6	1	16,7%				0
Ganga	3	2	66,7%				0
Sud Ubangi	2	1	50,0%	0	0	0	0
Bulu	2	1	50,0%				0
Total	8171	3954	48,4%	55	17	13	30

*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province qui sont en cours de ventilation pour être classifiés par zone de santé.

NA : Non Applicable.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province pour la journée du 28 septembre 2026

DPS	Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	28	6	34	17	6	9	0	23	15
Bas Uélé	150	3	153	10	3	140	0	13	0
Ituri	1 123	77	1200	128	74	995	0	198	123
Nord-Kivu	966	39	1005	131	39	811	0	170	101
Sud Ubangi	56	0	56	3	0	0	0	3	1
Tshopo	173	0	173	9	0	164	0	9	1
Total Général	2 496	125	2 621	298	122	2 119	0	416	241

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours des 21 derniers jours

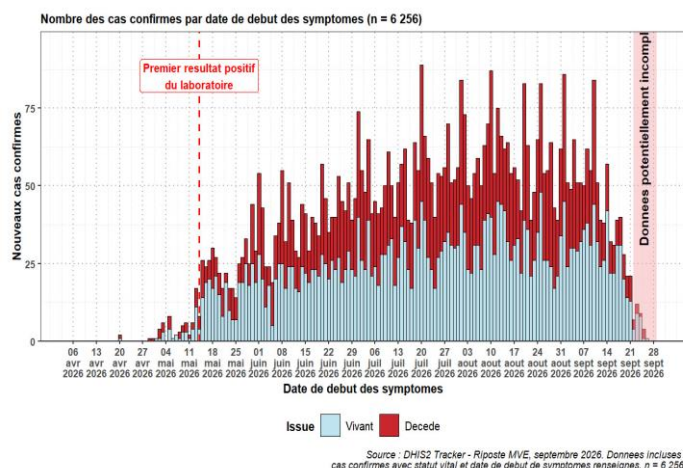
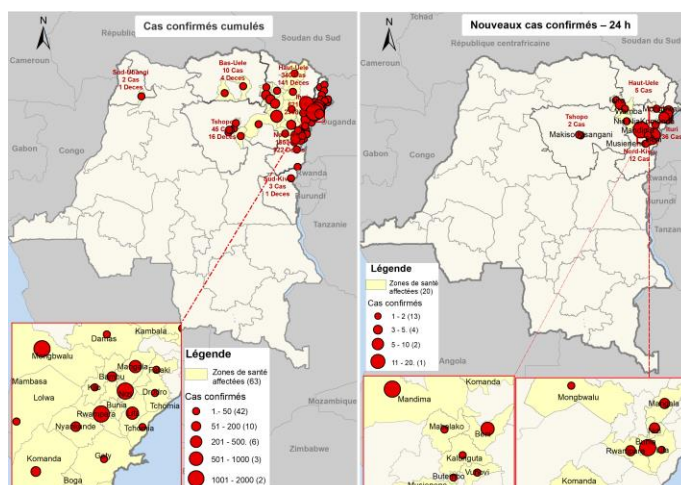


Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24 heures et cumuls) par zone de santé.



1. COORDINATION

1.1. Principales Actions

- Appui aux activités de réponse dans les provinces affectées à travers les piliers techniques.

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1. Surveillance épidémiologique

2.1.1. Principales Actions

Au décours de la journée du 28 septembre 2026, **2 621** alertes ont été remontées, **2 539** (96,9 %) ont été vérifiées, dont **420** (16,5 %) ont été validées comme cas suspects et **416** (99,0%) ont été investiguées. Ainsi, 241 cas suspects ont été transférés vers les CT/CTE (Tableau 3).

Parmi **30 159** contacts en cours de suivi, **24 717** contacts ont été vus au cours des dernières 24 heures, soit une proportion de suivi de **82,0%**, supérieure à celle de la veille (**75,9%**) mais qui demeure sous-optimale au seuil requis (95,0%). Au Sud Ubangi, cette proportion était de 93,9 % (92/98), 85,9 % (159/185) au Bas-Uélé, 84,4% (10 534/12 476) en Ituri, 83,2 % (634/762) à la Tshopo, 80,1 % (11 921/ 14 876) au Nord Kivu et 78,1 % (1 377/1 762) au Haut Uélé.

2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

2.2.1. Principales actions

Huit (8) alertes ont été notifiées aux PoE/PoC au cours de la journée, dont cinq (5) en Ituri et trois (3) au Nord-Kivu. Trois alertes vivantes ont été validées, dont deux transférées (taux de transfert de 66,7 %), et quatre corps sans vie interceptés ont été acheminés pour le swab.

Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 28 septembre 2026

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Tshopo	Global
Complétude des rapports	95,0% (57/60)	90,5% (19/21)	44,4% (8/18)	84,8% (84/99)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	100%	100%	100%	100%
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	154 875	89 299	7 093	251 267
% des voyageurs screenés	96,8%	97,3%	96,3%	97,0%
% des voyageurs ayant lavé les mains	96,7%	97,3%	96,5%	96,9%
% des voyageurs sensibilisés	98,4%	97,3%	100,0%	98,1%
Nombre d'alertes notifiées	5	3	0	8
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	2	1	0	3
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	3	1	0	4
% des cas suspects transférés au CTE/CT	50,0%	100,0%	NA	66,7%
% des corps sans vie swabés/sécurisés	100,0%	100,0%	NA	100,0%
% des cas suspects investigués dans 4 h	100,0%	100,0%	NA	100,0%

2.3. Laboratoire

2.3.1. Principales actions

- **Ituri : 36 nouveaux résultats positifs** (27 vivants et 9 décès) sur 200 échantillons reçus et analysés (**positivité : 18,0 %**).
- **Nord-Kivu : 12 nouveaux résultats positifs** (5 vivants et 7 décès) sur 140 échantillons reçus et analysés (**positivité : 8,6 %**).
- **Haut-Uélé : 5 nouveaux résultats positifs** (4 vivants et 1 décès) sur 20 échantillons reçus et analysés (**positivité : 20,0 %**).
- **Tshopo : 2 nouveaux résultats positifs** (2 vivants) sur 10 échantillons reçus et analysés (**positivité : 25,0 %**).
- **Bas Uélé : 10 échantillons reçus et analysés** (1 vivant et 1 décès), tous sont revenus négatifs.

2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.4.1. Principales actions

- **Ituri** : 14 rings ont été ouverts sur 33 (42,4 %), 32 ménages décontaminés sur 37 (86,5 %) et 14 FOSA décontaminées sur 19 (73,7 %). Sur 82 alertes EDS (dont 8 reports), 58 EDS ont été réalisés (70,7 %) et 58 corps swabés.
- **Nord-Kivu** 20 rings ont été ouverts sur 27 (74,1 %), 7 ménages décontaminés sur 27 (25,9 %) et 19 ESS décontaminées sur 24 (79,2 %). Au total, 184 FOSA ont été suivies, 582 prestataires briefés et 38 EDS réalisés sur 56 alertes.
- **Haut-Uélé** : 2 rings ont été ouverts sur 4 (50,0 %), 6 ménages décontaminés sur 6 (100 %) et 3 ESS décontaminées sur 3 (100 %). Sur 5 alertes EDS, 2 EDS ont été réalisés et 2 corps swabés.

- **Tshopo** : 18 ESS ont été suivies dans 6 ZS et 186 prestataires briefés. En cumul, 25 ménages sur 29 (86,2 %) et 33 ESS sur 33 (100 %) ayant accueilli un cas confirmé ont été décontaminés dans les 48 heures.
- **Bas-Uélé** : 5 ESS suivies à Viadana et à Buta, démarrage à Ganga d'une formation PCI/WASH de 70 participants (FHI 360) ; 2 corps swabés à Buta et à Ganga et un échec à Poko.

2.4.2. Défis

En Ituri, l'ouverture des rings demeure faible (42,4 % ; 14/33), 19 corps n'ont pas été swabés et les activités sont suspendues à Nizi pour cause d'insécurité. **Au Nord-Kivu**, la décontamination des ménages reste limitée (25,9 % ; 7/27), aucun ménage décontaminé n'a été doté en kit (0/7) et la promptitude/complétude des rapports PCI est de 68,8 % (11/16 ZS). **Au Haut-Uélé**, incomplétude de rapportage (57,1 % ; 4/7 ZS) ; deux rings n'ont pu être ouverts à Pawa (AS Fungula et Gbonzunzu) en raison de tensions communautaires. **À la Tshopo**, seuls 2,0 % des ESS (2/99) ont obtenu un score PCI supérieur à 80 % ; dotation en kits PCI/EHA dans les ménages reste limitée à 40,0 % (20/50) et l'incinérateur de l'HGR de Makiso-Kisangani demeure en panne. **Au Bas-Uélé**, 2 triages sur 3 ne sont pas fonctionnels à Buta et l'acceptation des EDS reste faible.

2.5. Prise en charge holistique

2.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 93 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 80 sorties, dont 11 guérisons. Au total, 381 patients demeuraient en isolement à la fin de la journée, Le taux d'occupation des lits était de **37,5 %** ; 360 patients ont bénéficié de repas chauds et les enfants sous LNPE/SLM ont été intégralement couverts au CTE (9/9), à la crèche (9/9) et dans la communauté (33/33) ; 39 malades sont en état critique.
- **Au Nord-Kivu**, 69 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 48 sorties, sans guérison. Au total, 366 patients demeuraient hospitalisés dont 249 dans les structures normées. Le taux d'occupation des lits était de **70,3 %**.
- **À la Tshopo**, 6 nouvelles admissions ont été enregistrées. Sept sorties ont été rapportées, dont 4 guéries. Neuf patients demeuraient en isolement à la fin de la journée, soit un taux d'occupation de **29,0%**.
- **Au Bas-Uélé**, 2 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 4 sorties dont 2 guérisons. Trois patients demeuraient en isolement à la fin de la journée.

2.5.2. Défis

- **En Ituri**, faible capacité d'accueil de certains CTE/CT et l'insuffisance de la prise en charge alimentaire demeurent préoccupantes.
- **Au Bas-Uélé**, l'absence de CTE normé et d'ambulance pour le transfert des malades demeure un défi opérationnel majeur.
- **À la Tshopo**, la présence continue de cas confirmés en isolement nécessite le maintien des mesures de prévention et contrôle de l'infection.

2.6. Vaccination

2.6.1. Principales actions

- **En Ituri**, 66 personnes ont été vaccinées le 28 septembre avec l'appui de MSF, dont 34 femmes et 32 hommes, sans MAPI notifiée. Le cumul atteint 602 personnes vaccinées, dont 251 femmes et 351 hommes. Les activités de vaccination et de recherche sur l'efficacité du vaccin ERVEBO contre la MVE-BDBV se poursuivent.
- **Au Bas-Uélé**, 19 PPL et TPL ont été vaccinés à Buta, portant le cumul provincial à 1 019 personnes vaccinées sur une cible de 13 202 (7,7 %). La vaccination compassionnelle se prépare à Aketi et à Viadana.
- **À la Tshopo**, la rupture de vaccin persiste. Au niveau national, 6 897 personnes ont été vaccinées, soit 100,3 % de la cible pré-enregistrée.

2.6.2. Défis

À la Tshopo, rupture de vaccin ERVEBO dans un contexte de forte demande communautaire ; les deux prestataires confirmés le 28 septembre n'étaient ni vaccinés ni sous PEP.

Au Bas-Uélé, mise en marche des UCC et disponibilité du micro-plan validé et des fonds de la vaccination.

En Ituri, la cible des PPL/TPL reste à redéfinir ; aucun taux de couverture fiable n'est calculé sur cette base dans la présentation.

2.7. Continuité des Soins

2.7.1. Principales actions

- **À la Tshopo**, les activités du 28 septembre comprennent l'évaluation du Centre médical CELPA, l'élaboration du plan de redressement du CM Makiso-Kisangani, la validation du plan de travail du PCSSE pour la quatrième semaine de septembre et le suivi des PPL au CTM et au CTE. Sur les 51 agents de l'établissement évalué, 40 sont vaccinés ; un incinérateur fonctionnel y a été relevé, mais l'utilisation du thermoflash reste facultative.

2.7.2. Défis

À la Tshopo, baisse de l'utilisation des services, notamment de la maternité et des césariennes, dans l'ESS évalué ; la fermeture provisoire de l'ESS DHKis reste proposée face à la multiplication des cas confirmés et suspects.

2.8. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

2.8.1. Principales actions

- **En Ituri**, 11 389 visites à domicile ont touché 32 663 personnes ; 387 causeries éducatives ont réuni 2 448 personnes, 8 débats communautaires ayant touché 351 personnes et 37 sensibilisations de masse ayant touché 8 813 personnes. Au total, 304 alertes communautaires, dont 94 décès, ont été notifiées ; les 41 feedbacks et les 6 incidents enregistrés ont tous été résolus dans les 48 heures.
- **Au Nord-Kivu**, la CREC a appuyé la formation des relais communautaires à Katwa et facilité, autour des derniers cas, le listage de 15 contacts à Butembo et de 11 à Lubero ainsi que la décontamination d'un poste de santé à Manguredjipa ; quatre réticences restent en négociation à Butembo.
- **À la Tshopo**, 208 visites à domicile ont touché 1 165 personnes, 4 causeries éducatives ayant permis de toucher 162 personnes et 12 séances de sensibilisation de masse (15 286 personnes touchées). Les 27 alertes communautaires notifiées (22 à Makiso-Kisangani et 5 à Tshopo) ont été traitées, les 2 feedbacks résolus et les 2 refus levés.
- **Au Bas-Uélé**, 143 visites à domicile et 3 sensibilisations de masse ont touché 1 859 personnes à Viadana et à Ganga. À Titule, une rumeur sur la vaccination des élèves a poussé des parents à retirer leurs enfants des écoles ; une réunion d'urgence et un plaidoyer auprès de la radio Bima ont suivi.

2.9. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

2.9.1. Principales actions

- **Nord-Kivu**, 16 cas confirmés ont bénéficié d'interventions SMSPS dans 5 des 6 ZS ayant notifié. Les équipes ont accompagné 25 ménages d'enfants séparés et orphelins (100 %), annoncé 103 résultats, dont 17 positifs, et réinséré 5 guéris.
- **Ituri**, 17 personnes parmi les nouveaux cas confirmés, 109 confirmés en cours de suivi sur 150 (72,7 %), 32 nouveaux suspects sur 93 (34,4 %) et 111 suspects en cours de suivi sur 120 (92,5 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS. Les équipes ont soutenu 459 accompagnants et 79 PPL, suivi 16 guéris sur 23 en communauté (69,6 %) et annoncé 62 résultats, dont 17 positifs.
- **À la Tshopo**, les équipes ont apporté un soutien psychologique à 2 cas confirmés en cours de suivi et réalisé la psychoéducation de 30 suspects et de 147 personnes ; 3 résultats, tous négatifs, ont été annoncés et la famille du chef du village de Bafwandambo a été réinsérée après la guérison de son enfant.

2.9.2. Défis

- **En Ituri**, renforcer en urgence les capacités des psychologues et des agents psychosociaux pour les interventions autour des cas à Mandima.
- **À la Tshopo**, former les agents psychosociaux de Wanie-Rukula et de Bafwasende, renforcer les moyens de communication et de déplacement du pilier, et apporter un soutien matériel à la famille du guéri de Bafwandambo.

2.10. Logistique

2.10.1. Principales actions

- **Au Nord-Kivu** réception de 97 colis d'intrants PCI offerts par l'OMS et livraison de médicaments et d'intrants PCI de l'UG-PDSS à Masereka.
- **À la Tshopo**, suivi de la construction du CTE de Bafwasende, appui à la mobilité des piliers et réception des intrants pour le traitement compassionnel (INRB).
- **Au Bas-Uélé**, remise de chaises, de matelas et d'intrants PCI et de prise en charge aux ZS de Ganga et de Viadana ; poursuite de la construction du centre de transit de l'HGR de Buta.

2.11. Sécurité

2.11.1. Principales actions

- **Au Nord-Kivu**, le pilier Mitigation des risques et sécurité a couvert à 100 % les équipes EDS pour 3 enterrements de cas confirmés à Beni et 3 swabs dans la ZS de Katwa

2.12. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)

2.12.1. Principales actions

- **En Ituri**, 36 membres du personnel (11 femmes et 25 hommes) ont été briefés sur la PSEAH et ont signé le code de bonne conduite ; 273 personnes ont été sensibilisées.
- **Au Nord-Kivu**, 170 personnes ont été sensibilisées sur la PSEAH, 88 à Goma et 82 à Beni ; 40 dépliants ont été distribués.

2.12.2. Défis

Au Haut-Uélé, Au niveau national, seules 2 DPS sur 7 ont rapporté leurs activités PSEA (28,6 %) et les CBCM restent peu efficaces.

MESSAGES CLÉS

- Une transmission communautaire active et soutenue demeure observée dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu, du Haut-Uélé, de la Tshopo et du Bas-Uélé. Tandis que la province du Sud Ubangi n'a notifié aucun cas confirmé au cours des dernières 24 heures.
- Des progrès à consolider sont enregistrés dans le domaine des investigations épidémiologiques : La quasi-totalité (**99,0 %**) des suspects a été investiguée dans les 24 heures suivant leur notification. Toutefois, le taux de suivi des contacts est supérieur par rapport à la veille (**82,0 vs 73,9%**).
- Renforcer la surveillance, la prise en charge, la PCI, la logistique et l'engagement communautaire, en privilégiant l'augmentation des capacités des CTE/CT au Nord-Kivu, le transfert rapide des suspects et l'isolement des cas confirmés. **A Mangobo (Tshopo)**, deux cas confirmés évadés du CTE restent signalés à domicile.
- Renforcer la préparation et la réponse à la MVE-B dans le corridor fluvial et les zones environnantes, notamment au Sud-Ubangi, par la recherche active, le suivi des contacts et la disponibilité des intrants. Poursuivre la surveillance transfrontalière avec le Soudan du Sud.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17^e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.



TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17

Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Chargé des opérations

Dr KOMBE NGWAMA John

Equipe de rédaction

Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard

Dr KATUSI BISELENGE Jules

Madame MAYELE AFUA Marie

Dr DIUR MANANASHI Floryan

Mr KAMUINA KEBELA John

Contact :

www.insp.cd

contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151. www.sante.gouv.cd